ETIOLOGIES ET FACTEURS PRONOSTIQUES DES DÉTRESSES RESPIRATOIRES NÉONATALES DANS LE SERVICE DE NÉONATALOGIE DU CHU SOURÔ SANOU DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO)

Nom du présentateur : OUATTARA Ad Bafa Ibrahim

Auteurs et coauteurs : OABI et al.

Affiliations : Université Lédéa Bernard OUEDRAOGO

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

Détresse respiratoire:

- Pathologie fréquente en période néonatale: **7%** NNE à terme
- Cause majeure morbi-mortalité: **25%** NNE meurent chaque année PED(**OMS**)
- Peu de données au CHU-SS → intérêt présente étude

Objectifs 1/2

❑ Objectif général

Décrire le profil clinique, les facteurs étiologiques et pronostiques DRNN dans le service de néonatalogie du CHU-SS

❑ Objectifs spécifiques

❖ Déterminer la fréquence des DRNN au CHU-SS

❖ Décrire le profil clinique des NNES avec DR

Objectifs 2/2

❑ Objectifs spécifiques

❖ Identifier les étiologies des DRNN

❖ Analyser les facteurs associés aux décès des DRNN au CHU-SS

Matériel et méthode(s) 1/3

- **Cadre d'étude:** Néonatologie CHU-SS
- **Type et période:** Etude transversale **descriptive et analytique**

  collecte **prospective** allant du 1er mai au 31 octobre 2024 (**6mois**)
- **Critères d'inclusion:** NNE à terme (**37SA-41SA**) avec DR à l'admission

Matériel et méthode(s) 2/3

- **Collecte et analyse:**

- Données collectées sur fiche d'enquête puis saisies et analysées sur SPSS version 20.0

- Test de Chi^2 utilisé avec un seuil de significativité $p < 0,05$

Matériel et méthode(s) 3/3

- **Considérations éthiques:**

- Obtention de l'autorisation de collecte des autorités administratives du CHU-SS, Cheffe département pédiatrie
- Confidentialité des données respectée

Résultats 1/7

- **Fréquence hospitalière:**

167 DRNN colligés pendant la période sur 1080 admissions en néonatologie soit **15,46%**

Résultats 2/7

❑ Caractéristiques sociodémographiques

Variables	Effectifs (n=167)	Pourcentage (%)
Sexe		
Masculin	**95**	**56,9**
Féminin	72	43,1
Age (jours)		
< 3	**103**	**61,7**
[3 – 5 [	49	29,3
≥ 5	15	9
Résidence		
Urbain	67	40,1
Rural	**100**	**59,9**

Résultats 3/7

Caractéristiques obstétricales

Variables	Effectif (n=17)	Pourcentage (%)
Suivi prénatal		
Oui	141	**84,4**
Non	26	15,6
Nombre SPN		
< 4	43	25,7
[4 – 6[	75	**44,9**
≥ 6	19	11,4
Gestité		
< 3	65	18,9
[3 – 6[	83	**49,7**
≥ 6	19	11,4
Parité		
< 3	86	**51,5**
[3 – 6[	74	44,3
≥ 6	7	4,2
Mode d'accouchement		
Voie basse	109	**65,3**
Césarienne	58	34,7

Résultats 4/7

❑ Caractéristiques cliniques

Variables	Effectif (n=167)	Pourcentage (%)
Mode d'admission		
Direct	42	25,1
Evacué	23	13,8
Référé	**102**	**61,1**
Réanimation		
Oui	**87**	**52,1**
Non	80	47,9
Statut NNE		
Hypotrophique	35	21
Eutrophique	**84**	**50,3**
Macrosome	48	28,7
Degré DR		
Légère	113	67,7
Modérée	47	28,1
Sévère	**7**	**4,2**

Résultats 5/7

❑ Etiologies

Variables	Effectif (n=167)	Pourcentage (%)
Asphyxie périnatale	105	**62,9**
Infection néonatale	46	**27,6**
Tachypnée transitoire	9	**5,4**
Inhalation méconiale	7	4,2

Résultats 6/7

- **Caractéristiques évolutives:**

- Durée d'hospitalisation: [1 – 5jours[plus représenté avec **58,10%**
- Guérison: **61,08%**
- Mortalité : **38,92%**

Résultats 7/7

❑ Facteurs associés aux décès:

- ❖ NNE issu de moins de 4 SPN: **p = 0,022**
- ❖ Gestité [3 – 6[: **p = 0,022**
- ❖ Parité [3 – 6[: **p = 0,017**
- ❖ Césarienne: **p=0,032**

Conclusion

DRNN:

- Fréquente au CHU-SS
- Prédominance masculine
- APN étiologie courante
- Compromet adaptation vie extra-utérine

→ Nécessité **meilleure collaboration Obstétrico-Pédiatrique**

Merci pour votre attention